



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Daniel León Muñoz Hermosilla
- RUN: 27.326.972-k
- Fecha de nacimiento: 05 de agosto de 2020
- Edad: 5 años 10 meses
- Sexo: masculino
- Escolaridad: kinder
- Establecimiento educacional: psicoeduka
- Nombre del cuidador/tutor legal: Madre Katherine Hermosilla
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: evaluación debido a desregulaciones emocionales frecuentes
- Tiempo de evolución: Padres refieren se realiza diagnóstico de TEA año 2026, se realizó test de ADOS-2 sugerente. Estuvo asistiendo a escuela de lenguaje en donde acudía sin mayores inconvenientes a los 4 años, desde allí no se reportan episodios de desregulación. Luego ingresa a colegio convencional, en donde presenta tendencia a desregulaciones frecuentes, por lo que padres deciden ingreso a psicoeduka, en donde se reporta tendencia a rechazo a asistencia, se reportan 3 episodios de desregulación emocional asociado a auto y heteroagresiones. A padres les llama la atención que en escuela de lenguaje no sucediera esto.
- En reportes de psicoeduka se reportan desregulaciones con auto y heteroagresiones, gritos, frente a solicitud de guardar juguetes, requiere de anticipaciones, tendencia a rigidez cognitiva. Logra responder a contención emocional de TO en una ocasión. En otra ocasión, se desregula frente a solicitud de iniciar una actividad. Se describe que se observa que los principales desafíos para la transición de espacios y desapego con su mamá. Padres se observan receptivos a sugerencias.
- Destaca además que ambos padres realizan viaje por algunos días, sin Daniel, luego de esto madre observa tendencia a estar mas apegado a ella, con dificultad para ingresar a psicoeduka, al llegar madre de su salida Daniel manifiesta su enojo que madre haya salido. Madre describe que antes solo presentaba desregulaciones fuera de casa,

últimos días, observan además desregulaciones en casa. Padres tienen planificado viaje a otro país en octubre, están pensando en cancelarlo.

- Con respecto a alimentación es selectivo pero si recibe proteínas tipo carne, pollo, pescado, y sueño actualmente sin grandes dificultades, estuvo antes con melatonina y vigisom actualmente no. Padres refuerzan higiene del sueño. Uso de pantallas escaso.
- De animo padres lo observan bien, mantiene capacidad de disfrutar juegos, afectivo, no se observan señales de retraso a nivel psicomotor, no lo observan deprimido, si observan principalmente necesidad de predictibilidad constante, frente a pequeños cambios se observa hipervigilante e irritado. Padre describe que a su edad él presentaba conductas similares.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: prematuro 36 semanas
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: no
- Psicoterapia previa: en psicoeducación actualmente, a diario, estuvo en escuela de lenguaje año 2025
- Conductas autolesivas / ideación suicida: conducta autolesiva si al desregular principalmente en transiciones, madre refiere que antes solo en psicoeducación, ahora también en casa. Sin ideación suicida.
- Antecedente de EEG realizado normal (con privación sueño)
- Habría estado con melatonina y vigisom para el sueño

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes prematuro 36 semanas por preeclampsia, sano actualmente. Diagnóstico en febrero 2026 de TEA, con ADOS-2 sugerente.
- Tratamientos actuales: sin fármacos
- Alergias: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: padre sospecha TEA
- Contexto psicosocial relevante: Familia constituida por ambos padres, hermanas de 20, 10, 7. Viven todos en mis casa. Dinámica familiar sin disfuncionalidad

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada
- Actitud: cooperador, no se desregula cuando padres hacen relato de sus conductas
- Psicomotricidad: se observa normal
- Lenguaje: lenguaje expresivo alterado
- Pensamiento: no evaluable
- Ánimo impresiona eutímico, (reporta de padres es eutímico)
- Contacto visual adecuado
- Juicio de realidad: no evaluable
- Insight: no evaluable

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no
- Factores de riesgo:
- Factores protectores:

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TEA
- Diagnósticos secundarios: t. Lenguaje, t. procesamiento sensorial, tendencia a la desregulación emocional, **obs t. Ansiedad de separación**

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: azymol 1mg/ml : 2 ml por semanas, si tolera bien aumentar a 3 ml
- Intervenciones psicosociales: psicoeducación en relación a la necesidad de predictibilidad, de anticipación, de necesidad de estructura
- Derivaciones:
- Continuar sesiones con TO Y fonoaudiología
- Solicito hemograma, cinética del hierro, niveles vitamina D, niveles vitamina b12
- Control en 1 mes

- **10. SEGUIMIENTO**

- Fecha próximo control:
- Red de apoyo: ambos padres, familia extendida
- Indicaciones a cuidadores: Se refuerza psicoeducación acerca de necesidad de predictibilidad y anticipación constante, de dificultades a nivel sensorial y estrategias sensoriales también de regulación emocional. Se psicoeduca con respecto a posibles RAM de fármaco, en caso de dudas dar aviso a tratante.

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad: psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional: 105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 10 de junio 2026